

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

STATUS OPHTALMOLOGIQUE

INSPECTION ŒIL ET ANNEXES

- Inspection de la conjonctive:

Tout en déplaçant les paupière pour visualiser la conjonctive bulbaire, l'examineur demande au patient de regarder en :

- *Tout droit*
- *Haut* (éversion de la paupière inférieure)



- *(Haut à droite)*
- *(Haut à gauche)*
- *Bas* (éversion de la paupière supérieure)



- *Bas à gauche* (éversion de la paupière supérieure) pour visualiser la glande lacrymale supérieure



- *Bas et en bas à droite (éversion de la paupière supérieure) :*



L'examineur refait ce test avec l'autre œil.

EVERSION DE LA PAUPIÈRE SUPÉRIEURE

- *L'examineur demande au patient de regarder vers le bas.*
- *Il saisit les cils d'une main.*
- *Il place un coton-tige sur la paupière supérieure qu'il utilise comme pivot pour pratiquer l'éversion de la paupière supérieure.*
- *L'examineur inspecte la conjonctive palpébrale supérieure.*



EXAMEN DU CHAMP VISUEL

- But : tester le champ visuel
- Démarche :
 - *Faire un œil après l'autre.*
 - *Diviser le cadrans en 4 et placer ses mains dans les cadrans (et non pas entre deux cadrans).*
 - *L'examineur demande au patient de se couvrir un œil, de fixer son nez puis d'indiquer le nombre de doigt qu'il perçoit.*



- *L'examineur lui demande tout en fixant son nez, d'indiquer la somme des doigts qu'il perçoit*



ETENDUE DU CHAMP VISUEL

- But : évaluer l'étendu du champ visuel
- Démarche :
 - Faire un œil après l'autre.
 - *L'examineur demande au patient tout en regardant son nez de lui indiquer lorsque qu'il voit le doigt et d'indiquer également l'origine du doigt.*
 - *L'examineur place ses doigts dans la zone non-vue du patient, c'est-à-dire derrière ce dernier et l'examineur ramène ses mains vers lui.*



OCULOMOTILITÉ

- But : évaluer la capacité musculaire à bouger les yeux .

⚠ Pas besoin de cacher un oeil

- Démarche :

- Fixation visuelle

L'examineur demande au patient de fixer son regard sur un objet et pendant ce temps l'examineur évalue la stabilité de la fixation et recherche notamment des mouvements inopinés

- Poursuite oculaire

L'examineur demande au patient de suivre du regard, le mouvement du doigt de l'examineur sans bouger la tête.

Attention :

- Le mouvement doit être stable, prévisible, harmonieux
- Rechercher un nystagmus notamment en fin de mouvement
- Lors du regard vers le bas, l'examineur soulève avec ses doigts les paupières supérieures



- Saccades

L'examineur place son doigt sur le plan horizontal gauche. Il demande au patient de fixer son nez. Il demande ensuite au patient de fixer le doigt sans bouger la tête. Puis, de fixer à nouveau le nez et revenir après vers le doigt. Il répète ce test sur le plan horizontal droit, puis vertical haut et finalement vertical bas. Dans ce dernier plan, l'examineur soulève les paupières supérieures.

Le patient réalise des mouvements oculaires aller-retour nez-doigt rapides qui correspondent à des saccades.

- Convergence

L'examineur demande au patient de fixer de suivre les mouvements du doigt. L'examineur rapproche son doigt en zigzaguant vers l'arcade nasale du patient. Il observe le myosis à la convergence.



- Test des 6 muscles extra-oculaires

L'examineur demande au patient de regarder :

- à gauche
- à droite
- en haut à gauche
- en haut à droite
- en bas à gauche
- en bas à droite

Lorsque le patient regarde en bas, l'examineur lui soulève les paupières supérieures

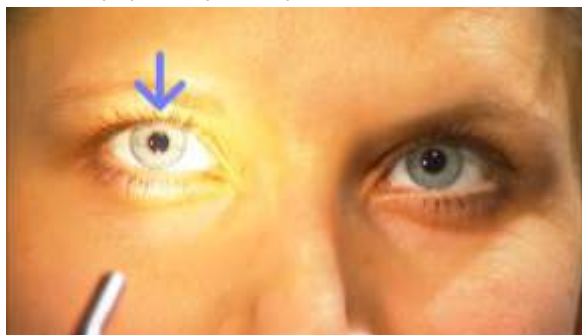
EXAMEN DES PUPILLES

- Diamètre

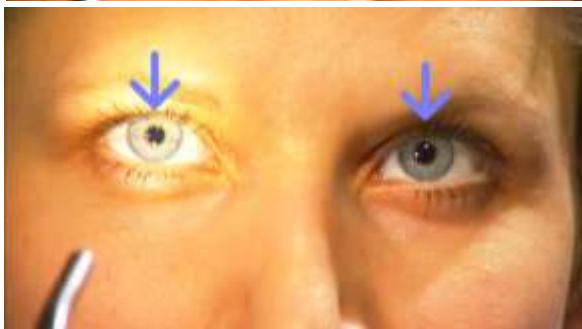
- *L'examineur observe si les pupilles ont un diamètre identique.*
- Isochores : pupille symétrique vs anisochores : pupille asymétrique.

- Réflexe pupillaire photomoteur

- *L'examineur demande au patient de regarder tout droit. Il éclaire une pupille et évalue la constriction de la pupille ipsilatérale pour tester le réflexe direct.*



- *Il éclaire la même pupille une deuxième fois et évalue la constriction de la pupille controlatérale pour tester le réflexe consensuel.*



- Refaire de ces deux tests avec en éclairant l'autre oeil.

- Test de la lumière d'alternance :

L'examineur éclaire très rapidement une pupille puis éclaire l'autre.

Ce test permet en cas d'asymétrie de la vision avec une baisse de l'acuité visuelle d'un côté, de mettre en évidence un déficit pupillaire afférent causé par une neuropathie optique. S'il y a une neuropathie d'un côté, au moment où on éclaire la pupille du côté malade, la pupille devrait se dilater.

- Réflexe pupillaire à la convergence :
Cf. chapitre précédent.

ACUITÉ VISUELLE

- Vision de près :
 - L'examineur demande au patient de mettre des lunettes (s'il en porte) et de couvrir un oeil avec sa main. Il donne au patient une carte de lecture et lui demande de lire à une distance de 40cm.
 - Le patient doit lui indiquer l'écriture la plus petite qu'il arrive à lire. Répéter ce test avec l'autre oeil.
- Vision de loin :
 - L'examineur demande au patient de mettre des lunettes (s'il en porte) et de couvrir un oeil avec sa main. Il lui demande de lire à haute voix les lettres que l'examineur montre sur le tableau.
 - Quantifier l'acuité : 10 / 10 ème = 100%, etc.
 - Répéter ce test avec l'autre oeil



VISION DES COULEURS

- Tests de confusion, table pseudo-isochromatique d'Ishihara :
 - L'examineur demande au patient de se couvrir un oeil et de lui indiquer le chiffre qu'il arrive à lire sur les tables qu'il lui présente.
 - Refaire ce test avec l'autre oeil.



EXAMEN DU FOND D'ŒIL AVEC PUPILLE NON DILATÉE

- L'examineur utilise un ophtalmoscope direct.
- Il s'assure que la correction de la dioptrie est bien sur zéro au départ.
- Pour examiner l'oeil droit du patient, l'examineur tient l'ophtalmoscope dans la main droite et examine avec son propre oeil droit.



- Pour examiner l'oeil gauche du patient, l'examineur tient l'ophtalmoscope dans la main gauche et examine avec son propre oeil gauche.



- L'examineur demande au patient de regarder droit devant lui.
- L'examineur se place au-dessus de la ligne horizontale et un peu en temporal par rapport au patient.
- L'examineur centre la lumière de l'ophtalmoscope sur l'oeil du patient.



- L'examineur maintient avec son autre main la paupière supérieure du patient.
- L'examineur se rapproche de l'oeil du patient tout en gardant la lumière de l'ophtalmoscope centrée sur la pupille du patient.



- L'examineur se rapproche jusqu'à être à 3-4 cm de distance du patient.
- L'examineur observe le nerf optique et le pôle postérieure de la rétine.

